

ITEM 295 : TUMEURS DE LA CAVITE BUCCALE, NASO-SINUSIENNES, DU CAVUM ET DES VOIES AERODIGESTIVES SUPERIEURES

Anatomie	- Cavité orale : lèvres, vestibule labial et jugal, gencives, régions rétro-molaires, plancher buccal, langue mobile, palais - Naso-pharynx = cavum : base du crâne (corps du sphénoïde), bourrelets tubaires, paroi pharyngée postérieure - Oropharynx : base de langue, vallécule, sillon amygdalo-glosse, voile du palais et piliers, amygdales linguales et palatines, paroi pharyngée postérieure - Pharyngo-larynx (hypopharynx) : sinus piriforme, paroi pharyngée postérieure, région rétro-crico-arythénoïdienne - Larynx : - Supra-glottique : épiglotte, replis ary-épiglottiques, aryténoïdes, bandes ventriculaires - Glottique : cordes vocales, commissures antérieure et postérieure - Sous-glottique : cricoïde				
	Aires ganglionnaires	→ Les cancers des VADS sont très lymphophiles (seules les petites tumeurs T1 du plan glottique ne nécessitent pas de traitement systématique des aires ganglionnaires) - 1 ^{er} relai de drainage : fréquemment situé en zone IIa - Curage ganglionnaire classique : - Zones IIa, IIb, III, IV ± étendu Ia-Ib (cavité orale ou face) - Bilatéral en cas de tumeur franchissant la ligne médiane			
		Classification de Robin	Ia : sous-mentale (cavité orale) Ib : sous-mandibulaire IIa : sous-angulo-mandibulaire	IIb : sus et rétro-spinale III : jugulo-carotidienne moyenne IV : sus-claviculaire	Va : spinale Vb : cervicale transverse VI : pré-laryngé (larynx)
Epidémiologie	= 15% des cancers de l'homme = 17 000/an = 4 ^{ème} le plus fréquent, 2% chez la femme (♂), mortalité élevée (10 000/an)				
	Cancer de la cavité buccale, de l'oropharynx, de l'hypopharynx et du larynx	- Touche essentiellement les hommes (95%) éthylotabagiques, fréquence maximale = 45 à 70 ans - Histologie : carcinome épidermoïde (90%), indifférencié (cavum), lymphome - Extension : lymphatique ++ (sauf cancer glottique), MT à distance (40%, mais < 10% au diagnostic) - Recherche systématique de cancer associé (20% des cas) : cancer de l'œsophage, du poumon ou autre cancer des VADS			
	Cancers spécifiques	- Cancer de l'éthmoïde : adénocarcinome, du aux poussières de bois → Maladie professionnelle pour les travailleurs du bois, jusqu'à 30 ans après l'exposition - Cancer du cavum (UCNT) : carcinome indifférencié, lié à EBV → Fréquent en Asie du Sud-Est et Afrique du Nord			
Diagnostic	Signes d'appel	- Douleur, ulcération persistante, trouble de la voix, trouble de la déglutition chez un alcoolotabagique : examen ORL (recherche d'ulcération ou tumeur bourgeonnante) → panendoscopie + biopsie sous AG - ADP cervicale : examen ORL + écho-ponction, voire cervicotomie exploratrice en 2nd intention (exérèse de l'ADP sans effraction capsulaire avec examen extemporané → si carcinome : curage ganglionnaire ± amygdalectomie homolatérale à visée histologique (micro-carcinomes fréquents) en l'absence de primitif)			
	Extension	- Examen ORL : inspection endo-buccale et oropharyngée, laryngoscopie indirecte, fibroscopie pharyngo-laryngée, rhinoscopie, cavoscopie, palpation cervicale, du plancher buccal et l'angle ± biopsie si accessible - Panendoscopie des VADS au tube rigide = systématique, sous AG, intubation non systématique : hypopharyngoscope, oesophagoscope (œsophage cervical), laryngoscopie + biopsies à la pince, examen clinique sous AG (réalisé après l'exploration au tube rigide : risque de saignement gênant l'exploration) - TDM cervico-thoracique injectée : recherche d'ADP infra-cliniques, MT pulmonaire ou cancer synchrone - IRM faciale pour les cancers du cavum, de la cavité buccale ou de l'oropharynx : extension tumorale - Sérologie EBV pour les tumeur du rhinopharynx et les carcinomes indifférenciés de l'oropharynx - Consultation stomato avec panoramique dentaire et remise en état : avant radiothérapie - Extension à distance : - PET-scanner si haut risque métastatique (≥ N2b, ADP IV et V) ou cancer du cavum - RP face/profil ou TDM thoracique → fibroscopie bronchique si anomalie - Bilan biologique hépatique → échographie hépatique si anomalie - Cancer synchrone : endoscopie digestive haute systématique (sauf si cancer du cavum ou des sinus)			
TTT	- Chirurgie d'exérèse (avec reconstruction) + curage ganglionnaire uni- ou bilatéral - Radiothérapie externe (sur la tumeur et les ADP), curithérapie : généralement en 6 semaines, après bilan stomato - Chimiothérapie : à base de cisplatine et/ou 5-FU essentiellement (+ taxotère si néo-adjuvante)				
Surveillance	- Examen général + ORL avec naso-fibroscopie au besoin : tous les 2 mois pendant 1 an, puis tous les 3 mois pendant 2 ans, puis tous les 6 mois pendant 2 ans, puis 1/an à vie - Dosage de la TSH après irradiation cervicale ou thyroïdectomie partielle : tous les 6 mois pendant 2 ans puis 1/an - TDM + panendoscopie des VADS de référence dans les 6 mois après le traitement, puis panendoscopie des VADS, fibroscopie oesophagienne, TDM thoracique, échographie hépatique, scintigraphie osseuse sur signe d'appel - Cancer du rhinopharynx : TDM ± IRM tous les 6 mois pendant 2 ans, puis 1/an jusqu'à 5 ans				

OROPHARYNX	Cancer de la base de la langue	SC	- Déviation homolatérale à la tumeur lors de la protraction de la langue - Induration de la base de la langue en arrière du V lingual à la palpation	
		PC	- Biopsie en laryngoscopie indirecte ou directe	
		TTT	- Radiochimiothérapie ± chirurgie (ablation de la base de la langue : mutilante, troubles de la déglutition, pouvant nécessiter une laryngectomie totale de nécessité), curage bilatéral → Pronostic sombre : évolution insidieuse (diagnostic retardé), infiltration diffuse dans le muscle lingual, lymphophilie bilatérale	
CANCER DE L'HYPOPHARYNX (15%)	= Carcinome épidermoïde bien différencié du sinus piriforme : fréquent, de pronostic grave (évolution insidieuse, ADP) - Epidémiologie : 50-60 ans, prépondérance masculine (95% des cas)			
	SF	- Gêne pharyngée latéralisée, puis dysphagie haute progressive - Otalgie réflexe unilatérale - ADP cervicale moyenne unilatérale (parfois surinfectée) : révélatrice dans 1/3 des cas - Tumeur volumineuse : dysphonie , dyspnée laryngée (envahissement laryngé ou récurrentiel), amaigrissement		
	SC	- Examen de l'hypopharynx au laryngoscope indirecte ou laryngo-fibroscope par un ORL : tumeur ulcéro-bourgeonnante du sinus piriforme , associée le plus souvent à une mobilité laryngée unilatérale		
	Dg	- Biopsie : carcinome épidermoïde - TNM : - T1 : limité à un siège isolé, larynx mobile - T2 : ↘ mobilité du larynx - T3 : > 4 cm ou héli-larynx bloqué - T4 : extension en dehors du larynx ou cartilagineuse		
	TTT	- Chimiothérapie néo-adjuvante → radiothérapie si régression tumorale suffisante (évite la laryngectomie totale) - Chirurgie d'exérèse = pharyngo-laryngectomie totale avec curage ganglionnaire bilatéral en cas d'échec de la chimio-radiothérapie ou si tumeur avancée : chirurgie très mutilante (trachéostomie, mutilation vocale), avec radiothérapie ou chimio-radiothérapie concomitante systématique → Pronostic grave = 20% de survie à 5 ans : récidence locale ou ganglionnaire, 2 ^{ème} localisation, métastase		
CANCER DU LARYNX (25%)	Cancer de l'étage glottique	= Carcinome épidermoïde différencié : prédominance masculine (90%) - FdR : tabac ++ , laryngite chronique avec dysplasie (tabac, malmenage vocal), RGO		
		SF	- Dysphonie ++ : précoce, progressive, permanente - D'installation récente, variable dans la journée - Chez un fumeur avec laryngite chronique : aggravation de l'enrouement, ne cède pas au TTT Autres (tardifs) : dyspnée laryngée , gêne pharyngée ou dysphagie , otalgie , ADP (rare)	
		SC	- Laryngoscopie indirecte au miroir ou nasofibroskopie : lésion tumorale glottique	
		PC	- Laryngoscopie directe sous AG au microscope : extension locorégionale, biopsie - TDM cervico-thoracique systématique (ou IRM cervicale) - T : - T1a : limité à une corde vocale mobile - T1b : limité aux 2 cordes vocales mobiles - T2 : ↘ mobilité de la corde vocale ou extension au fond du ventricule - T3 : héli-larynx bloqué - T4 : extension en dehors du larynx ou cartilage	
	TTT	- Corpectomie ou radiothérapie externe si cancer de la corde vocale mobile : très bon pronostic - Laryngectomie partielle ou subtotale reconstructive si cancer plus étendu - Chimiothérapie néo-adjuvante si cancer étendu → radiothérapie si régression suffisante - Laryngectomie totale avec trachéostomie définitif si cancer évolué → Pronostic favorable : 95% de survie à 5 ans si corde vocale mobile, 50% si laryngectomie		
	Cancer sous-glottique	- 1 ^{er} signe : dyspnée laryngée , d'apparition tardive - Radiothérapie + chirurgie : laryngectomie totale + curage cervical + radiothérapie → Pronostic peu favorable : extension fréquente au corps thyroïde, récidence trachéale, lymphophilie		
Cancer sus-glottique	= Bande ventriculaire et épiglotte : s'apparente plutôt aux cancers hypopharyngés - Signes d'appels tardifs : gêne pharyngée , dysphagie - TTT radio-chirurgical : laryngectomie totale ou horizontale sus-glottique + curage + radiothérapie			
RHINOPHARYNX	Carcinome indifférencié de type nasopharyngé (forme la plus fréquente) : diffère des autres cancers des VADS - Distribution géographique particulière : - Zone à haut risque : Asie du Sud-Est (Canton), Alaska (Inuits) - Zone à risque intermédiaire : Maghreb - Zone à risque faible : Europe, USA, Japon - A tous âge (non rare chez l'enfant et l'adolescent), touche les femmes dans 1/3 des cas - Non lié à l'alcool-tabagisme - Facteur viral EBV constant avec profil sérologique spécifique (↗ Ac anti-EBV) - Exposition : nitrosamine (alimentaire), formaldéhyde (maladie professionnelle)			

CANCER DU RHINOPHARYNX (7%)	SF	- ADP cervicale (50-90%) : haute, postérieure, rétro-mandibulaire ou sous-mastoïdienne, souvent bilatérale - Symptômes otologiques (25%, par obstruction tubaire unilatérale) : hypoacousie de transmission, autophonie, bourdonnement, otite séreuse unilatérale - Symptômes rhinologiques (20%) : obstruction nasale, épistaxis, rhinorrhée séro-sanglante - Symptômes neurologiques (10-15%) : névralgie du V ou du IX, céphalées persistantes, paralysie oculomotrice → Associations fréquentes de plusieurs symptômes (2/3 des cas), facilitant le diagnostic	
	SC	- Examen du cavum par rhinoscopie antérieure et postérieure au fibroscope : localisation généralement latérale ou postéro-supérieure, aspect ulcéro-bourgeonnant ou infiltrant - DD : végétation adénoïde hypertrophique, polype antro-choanal, fibrome naso-pharyngien de la puberté masculine, ulcérations spécifiques (tuberculose, sarcoïdose : rare)	
	PC	- Biopsie : - Carcinome indifférencié de type nasopharyngé (UCNT) - Lymphome, généralement non hodgkinien (10-20%) - Carcinome épidermoïde kératinisant : patient éthylo-tabagique, non associé à EBV - Bilan d'extension : - Atteinte osseuse basi-crânienne et des structures voisines : TDM injectée, IRM, audiométrie - PET-scanner systématique : MT principalement osseuse, parfois pulmonaire et hépatique	
	TTT	- Radiothérapie de 65-70 Gy : traitement de référence - Chirurgie : uniquement exérèse des reliquats ganglionnaires persistant > 2 mois après irradiation - Chimiothérapie : selon le stade évolutif ou en cas de métastases avérées → Pronostic : 30% de survie à 5 ans, dépend du type histologique et de l'ostéolyse basi-crânienne (péjorative)	
	= Rare, grandes variétés histologiques, peu lymphophile		
CANCER DES FOSSES NASALES ET DES SINUS (3%)	Cancer de l'ethmoïde	FdR : - Profession du bois (maladie professionnelle): même après une exposition courte (1 à 2 ans) - Autres substances : nickel, nitrosamine, goudron de houille, amiante... → Aucune influence notable de l'intoxication alcoolo-tabagique	
		SF	- Syndrome nasal : - Obstruction nasale unilatérale, rhinorrhée mucopurulente ± striée de sang - Epistaxis le plus souvent spontanée, unilatérale, répétée, sans cause locale - Syndrome oculaire : œdème de la paupière supérieure, dacryocystite, exophtalmie isolée, ptosis, paralysie oculaire, diplopie - Syndrome neurologique : douleur (rares au début), jusqu'à la névralgie faciale symptomatique
		SC	- Rhinoscopie antérieure : masse bourgeonnante hémorragique, ou banal polype réactionnel, unilatéral, cachant une lésion située plus haut (polype sentinelle) - Examen de la cavité buccale, de la face et de la région orbito-oculaire : recherche d'extension - ADP cervicale très rare
		PC	Biopsie par voie naturelle, généralement sous contrôle endoscopique : - Adénocarcinome le plus souvent - Autres (rares, sans lien avec les FdR professionnels) : tumeur nerveuse de la plaque olfactive (esthésio-neuroblastome), tumeur papillaire à potentiel malin (papillome inversé), mélanome Bilan d'extension par TDM + IRM du massif facial : extension à la face, l'orbite ou au crâne
		Evolution	- Locorégionale : vers l'orbite, l'endocrâne (de mauvais pronostic), la fosse temporo-zygomatique et la fosse ptérygo-maxillaire, les autres sinus, la cavité buccale et la face - Extension ganglionnaire : rare - Extension métastatique dans 20% des cas : poumon, os, cerveau
		TTT	- Chirurgical : exérèse large de la tumeur par voie ORL seule ou ORL + neurochirurgicale - Radiothérapie complémentaire systématique (sauf mélanome) - Chimiothérapie : indications limitées si très étendue, récidive ou certains types histologiques → Survie à 5 ans = 40-50%
	Cancer du sinus maxillaire	= Carcinome épidermoïde : sujet âgé surtout, favorisé par une infection naso-sinusienne chronique - Début algique, prédominant ou isolé : douleur dentaire à type de pulpite, névralgie faciale localisée au nerf sous-orbitaire avec anesthésie, algie faciale de type vasomotrice - Tableau de sinusite maxillaire aiguë ou chronique, avec rhinorrhée fétide et hémorragique - Signes buccodentaires : ulcération gingivale hémorragique, bombement alvéolaire - Tuméfaction de la canine et de la joue → Examen clinique, bilan et traitement similaire au cancer de l'ethmoïde, de pronostic plus mauvais	
Autre	- Tumeur de la cloison nasale : folliculite, rhinite vestibulaire traînante - Tumeur du sphénoïde : céphalées profondes ou postérieures, troubles ophtalmologiques (à proximité de l'apex orbitaire)		

Fdr	- Antécédents familiaux de cancer des VADS - Tabac : brûlure chronique, composants toxiques (nicotine...) et cancérigènes (hydrocarbures...) - Alcool : irritation locale (éthanol), dégradation hépatique (avitaminose A), solvant de substances cancérigènes du tabac - Irritation chronique de la muqueuse : mécanique (dent délabré, prothèse mal ajustée, morsure répétée), thermique (cigarette, alimentation brûlante) - Exposition professionnelle : métaux lourds (chrome, nickel), amiante... - HPV cancérigène = cancer des amygdales linguales et palatines et de l'oropharynx : de meilleur pronostic, recherche virale sur l'histologie par PCR, hybridation <i>in situ</i> ou surexpression de la protéine p16 optionnelle (épidémiologique)			
	Lésion pré-cancéreuse	Lésion blanche	- Leucoplasie (leucokératose) : plage blanchâtre, souple, ne se détachant pas au grattage - Lichen buccal = lichen plan, érosif ou atrophique : placard érythémateux, irrégulier, parsemé de ponctuation grisâtres, adhérentes, fines et serrées - Candidose chronique : notamment de forme hyperplasique - Papillomatose orale floride : touffes de fines villosités, blanches/rosées, extensives, très récidivantes	
		Lésion rouge	- Erythroplasie de Queyrat : plaques rouges, souvent étendues, superficielles, d'aspect velouté, à bords irréguliers → dysplasie sévère ou carcinome <i>in situ</i>	
TTT	Indication	- Tumeur : - T1/T2 : chirurgie (ou curithérapie si distante des structures osseuse) - T3/T4 : chirurgie + radiothérapie externe si possible, chimio-radiothérapie si non résécable → Privilégier une chirurgie exclusive à une radiothérapie exclusive si possible (la radiothérapie n'est pas réutilisable en cas de récurrence de cancer local) - ADP : - Curage ganglionnaire en cas de chirurgie de tumeur primitive - Radiothérapie externe des aires de drainage lymphatique si radiothérapie de la tumeur primitive - Curage systématique en cas de curithérapie sur tumeur N0 - Thérapie ciblée = cetuximab (Ac anti-EGFR) : utilisée en palliatif associé à une chimiothérapie		
	TTT adjuvant	- Antalgique de classe II ou III - Correction de la dénutrition : hyper-alimentation entérale (sonde gastrique si besoin) ou parentérale - PEC des comorbidités associées : hépatique, respiratoire (BPCO)		
	Complication des la radio-thérapie	- Mucite et dermite : dès le 15^{ème} jour, de l'érythème non douloureux, aux ulcérations saignantes, douloureuses, obligeant à une alimentation entérale ou parentérale - Hyposialie (systématique) : risque de carie (puis odontonécrose) → prophylaxie fluorée systématique - Agueusie - Mycose : risque permanent, très fréquent - Complication dentaire (après 1 an) : caries du collet, fracture par fragilisation de la dentine, abrasion progressive, coloration noire des dents, ondonécrose - Limitation de l'ouverture de la bouche par myosite rétractile des muscles masticateurs - Réhabilitation dentaire prothétique difficile - Ulcérations torpides et nécroses muqueuses : trouble trophique post-radique → à distinguer d'une récurrence tumorale		
		Ostéo-radionécrose mandibulaire	= Par thrombose de la vascularisation osseuse : généralement extensive - Apparition précoce (à 3 mois) ou jusqu'à 10 ans après - Fonction de la dose, de l'âge et de l'hygiène buccodentaire	
			TTT	- Médical : antibiothérapie, oxygénothérapie hyperbare - Chirurgical : curetage osseux étendu, voire mandibulectomie
		Prévention	- Avant irradiation : soins et hygiène buccodentaire avec détartrage, avulsion de toute dent non correctement traitable ou siège de parodontopathie → Dans un délai > 1-2 semaines avant la radiothérapie/curiethérapie - A vie : - Gouttière de fluoration : à vie, > 5 minutes/jour, à débiter après la fin de l'irradiation (après correction de la mucite) - Surveillance dentaire 1 à 2 fois/an - Avulsion dentaire sous antibiothérapie	